



Capítulo 4: La Arquitectura del Vínculo: Apego Adulto y Pareja

Más allá del prisma

La Arquitectura del Vínculo: Apego Adulto y Pareja — *Programa de Formación para Profesionales de la Salud Mental*

Más allá de la elección de objeto

El libreto edípico clásico

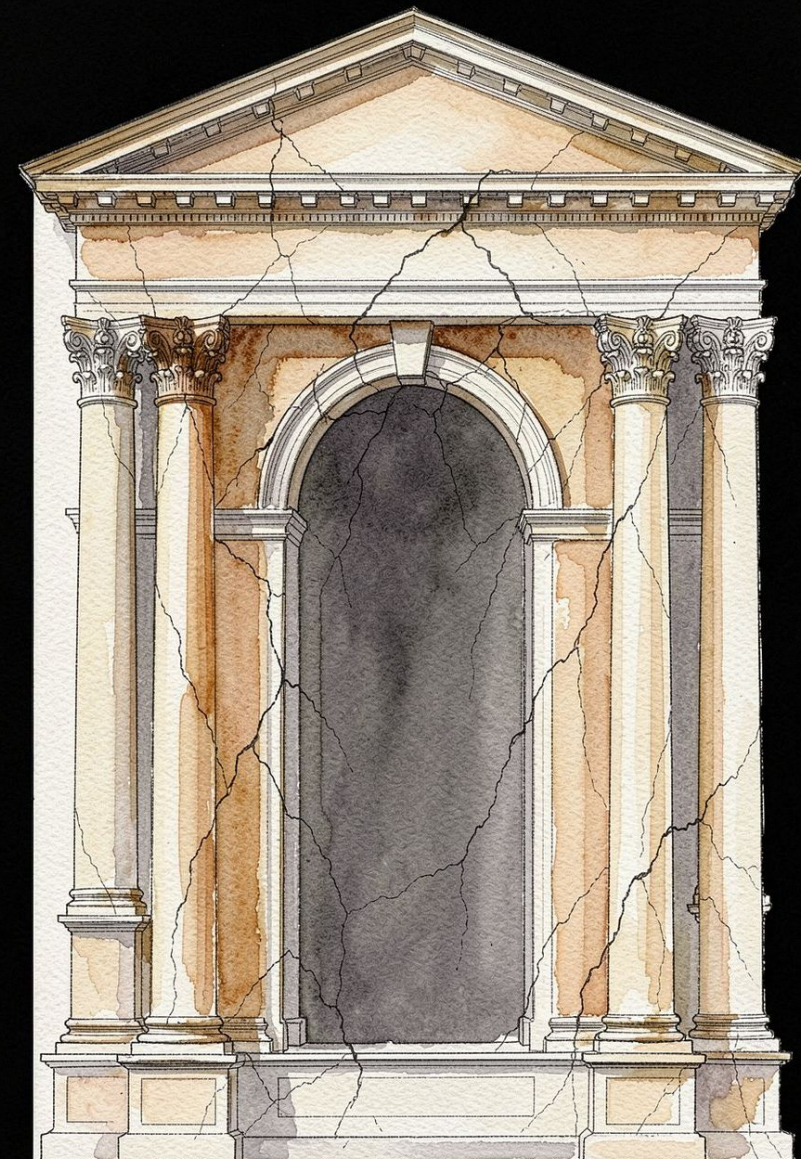
La metapsicología freudiana explicó el amor como **reédition**: el sujeto busca reencontrar sus primeras satisfacciones pulsionales en el objeto amoroso.

Una cartografía insuficiente

La clínica contemporánea revela que los conflictos de pareja involucran fallas en el sistema de apego, la neurobiología y la **regulación afectiva mutua**.

La Clínica de la Convergencia

Propone una arquitectura del vínculo que integra relaciones objetales, teoría del apego adulto y neurobiología de los neuropéptidos.





BOWLBY & FREUD

Los Modelos Operativos Internos

El libreto psíquico invisible

Bowlby formuló los **Modelos Operativos Internos**: matrices inconscientes y somáticas que filtran la percepción del vínculo, compatibles con la metapsicología freudiana.

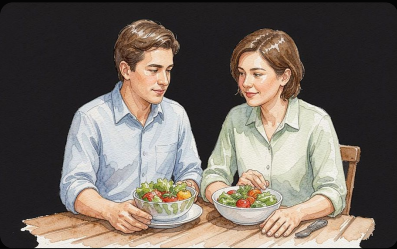
Representación de sí mismo

¿Soy digno de ser amado o mi destino es el rechazo?

Representación del otro

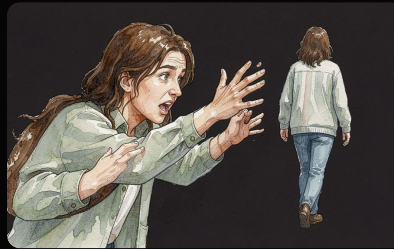
¿Es el objeto amoroso confiable y disponible, o una amenaza de abandono e intrusión?

Apego seguro vs. guiones traumáticos



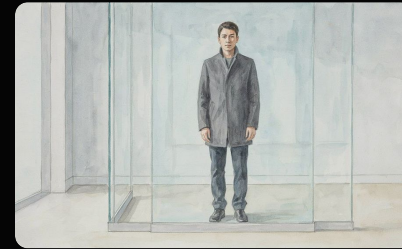
Apego Seguro

Tolera la ambivalencia, reconoce la alteridad del otro sin vivirla como amenaza. El amor se vive como **expansión y reciprocidad**.



Apego Ansioso-Ambivalente

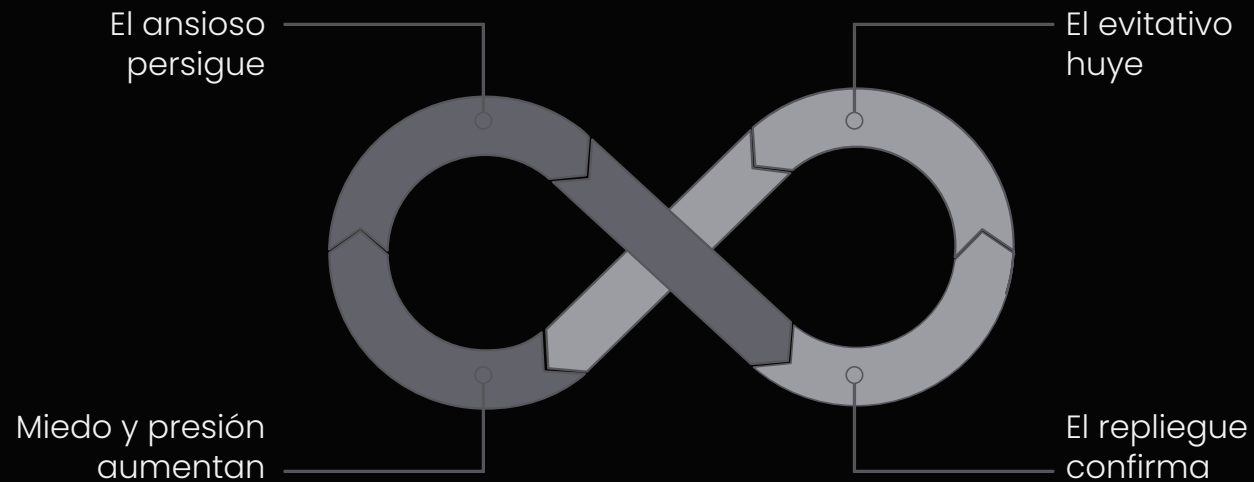
Hipervigilancia crónica ante la pérdida, terror al abandono, demanda reaseguradora constante. El sujeto busca **fusionarse para aplacar el desamparo original**.



Apego Evitativo

Autosuficiencia radical como defensa. Ante la intimidad, el sujeto se repliega, intelectualiza y huye, leyendo la cercanía como **invasión**.

La colisión sintomática: ansioso + evitativo



El drama clínico paradigmático: el acoplamiento entre un sujeto ansioso y uno evitativo genera una **espiral recursiva de sufrimiento**.

- ❏ El síntoma de la pareja no es una falla individual, sino la **cristalización de un diálogo de defensas arcaicas**.

Oxitocina: el doble filo del neuropéptido del apego

Función reguladora ideal

Inhibe la amígdala, desactiva el estado de lucha/huida y genera **calma, refugio y sincronía biológica** entre los amantes.

Paradoja clínica

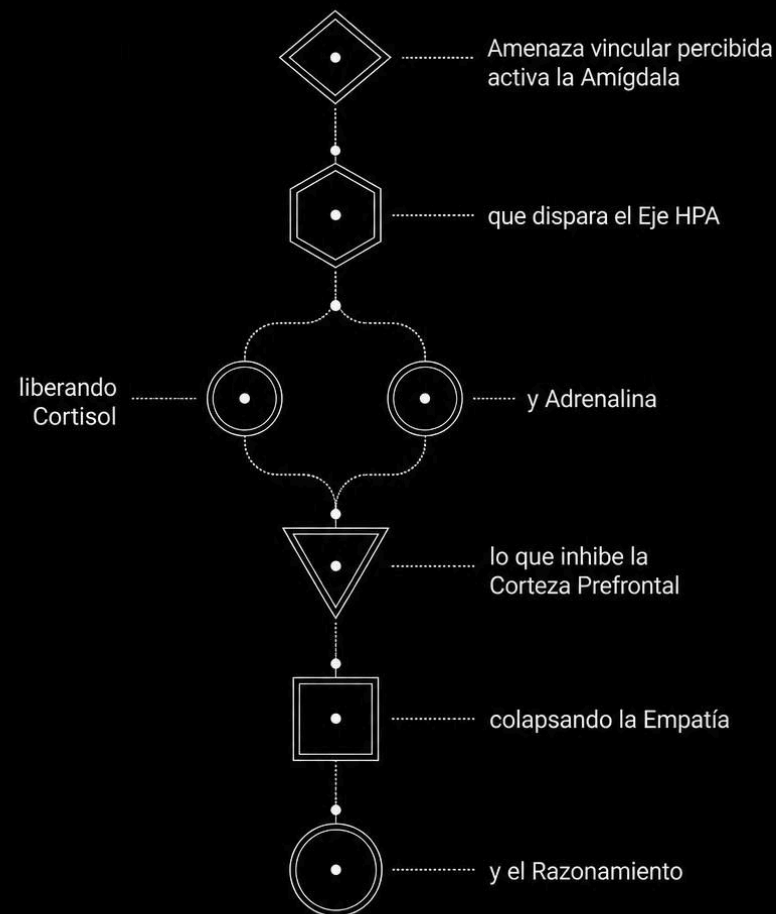
En sujetos con trauma temprano o apego ansioso, la oxitocina **amplifica** la hipersensibilidad al rechazo, los celos paranoicos y la suspicacia defensiva — intensifica el radar del peligro en lugar de calmarlo.



Vasopresina y el secuestro neurobiológico del vínculo

Vasopresina: regula el reconocimiento de pareja y la defensa territorial. En patología vincular, alimenta la celotipia extrema, el control obsesivo y la ira reactiva ante la sospecha de pérdida de exclusividad.

Secuestro amigdalino: en crisis aguda, el cerebro interpreta la ruptura vincular como amenaza vital. El eje HPA inunda de cortisol y adrenalina, inhibiendo la corteza prefrontal — la empatía y el razonamiento colapsan.



La intervención en la Clínica de la Convergencia

1 Reconocer el estado autonómico

En estado de secuestro autonómico, pretender que el paciente "escuche razones" o analice la perspectiva del otro es una **ilusión estéril**.

2 Descenso del tono autonómico

El paso previo e indispensable a cualquier elaboración analítica es la **regulación somática** y la restauración de la ventana de tolerancia afectiva.

3 El lazo amoroso como organismo vivo

Dos sistemas nerviosos que se calibran, se lastiman o se sanan mutuamente. La intervención trabaja sobre el **vínculo como unidad**, no sobre individuos aislados.



Fuentes

Material de referencia utilizado en este capítulo:

- **Capítulo 4 – Imagen de portada (Oxitocina/Vasopresina, conexión neural)**